



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN
INSTALASI GIZI
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pengorganisasian Gizi diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada Sukorejo

Pedoman Pengorganisasian Gizi yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi pedoman Pengorganisasian Gizi yang disesuaikan dengan undang-undang dan pelayanan terbaru di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pengorganisasian Gizi ini, pelayanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dapat lebih baik.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 15 Desember 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep



TIM PENYUSUN

Pelaksana

1. Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
2. Dr.dr.Aslichah, M.Kes.AFP
3. Saila Nur Siti Khodija, S.Gz
4. Riska Amelia Putri, S.Tr.Gz
5. Maylani Elina Pratiwi A.Md.Gz
6. Annisa' Dwi A.Md.Gz
7. Dewi Sofianilati, S.Tr.Gz
8. Aprilia A.Md.Gz



DAFTAR ISI

Judul.....	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Kebijakan.....	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Tujuan Umum	8
1.3 Tujuan Khusus.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	9
2.1 Deskripsi RS Prima Husada	9
2.2 Sejarah Institusi RS Prima Husada	9
BAB III VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN	11
3.1 Visi	11
3.2 Misi	11
3.3 Falsafah.....	11
3.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama	11
3.5 Tujuan.....	11
3.6 Motto	11
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RS PRIMA HUSADA.....	12
4.1 Bagan Organisasi	12
4.2 Keterangan/pengertian	13
BAB V STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI GIZI.....	15
BAB VI URAIAN JABATAN.....	16
6.1 Uraian jabatan	16
6.2 Tugas Klinis	22
BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA	25
BAB VIII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI	28
8.1 Seleksi calon karyawan	31
8.2 Pengembangan SDM	31
8.3 Pola ketenagaan dan kualifikasi SDM Instalasi Gizi.....	32
BAB IX KEGIATAN ORIENTASI	35
8.1 Kegiatan Orientasi di Instalasi Gizi	35
8.2 Kegiatan Orientasi	35
BAB X PERTEMUAN RAPAT.....	37
10.1 Pengertian	37
10.2 Tujuan.....	37
10.3 Kegiatan rapat	37
10.4 Jenis Rapat Instalasi Gizi.....	37
BAB XI PELAPORAN	38
11.1 Pengertian	38
11.2 Jenis Laporan	38
11.3 Laporan Tahunan	38



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 001.10/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025

TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI GIZI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menjamin pelaksanaan pelayanan gizi yang optimal di rumah sakit diperlukan adanya standar kebutuhan tenaga gizi secara lebih rinci yang memuat jenis dan jumlah tenaga gizi
- b. Bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 306.1/I-PER/DIR/III/2025 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perhitungan Pola Ketenagaan Berdasarkan Analisis Beban Kerja
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi
6. Kepdirjen Nomor HK-02-02-D-47104-2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit .
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 (01 November 2025 hingga tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI GIZI.

Pasal 1

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi digunakan sebagai acuan
dalam Organisasi Instalasi Gizi di Rumah Sakit Prima Husada.

Pasal 3

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 15 Desember 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep



**LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
INSTALASI GIZI**

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI GIZI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medic yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, maka rumah sakit harus melakukan upaya peningkatan mutu dan pelayanan medic baik melalui akreditasi, sertifikasi, ataupun proses peningkatan mutu lainnya. Secara komprehensif dan integratif yang menyangkut struktur, proses secara objektif.

Pelayanan gizi rumah sakit (PGRS) merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan paripurna rumah sakit dengan beberapa kegiatan, antara lain asuhan gizi pasien rawat jalan, asuhan gizi pasien rawat inap, penyelenggaraan makanan, serta penelitian dan pengembangan gizi (Departemen Kesehatan RI, 2006). Pelayanan gizi rumah sakit berperan dalam mempercepat penyembuhan pasien dan menjaga agar kondisi tubuh tetap sehat. Dengan gizi yang baik, daya tahan tubuh akan meningkat sehingga dapat mempercepat penyembuhan penyakit dan menghindari komplikasi penyakit lainnya serta dapat membantu mencegah kambuhnya penyakit.

Pelayanan Gizi Rumah sakit merupakan suatu penyelenggaraan makanan kepada pasien yang diawali dari perencanaan menu sampai pendistribusian dalam rangka pencapaian status gizi yang optimal melalui pemberian diet yang tepat. Dalam hal ini termasuk juga pencatatan dan pelaporan. Instalasi gizi merupakan suatu unit di rumah sakit yang memiliki tim kerja dengan kemampuan khusus untuk memberikan pelayanan gizi yang bermutu kepada pasien sehingga mempercepat proses penyembuhan pasien dan memperpendek masa rawatnya.

Faktor kebersihan penjamah atau petugas makanan dalam istilah populernya disebut higiene perorangan merupakan prosedur menjaga kebersihan dalam pengelolaan makanan yang aman dan sehat (Depkes, 2001). Prosedur menjaga kebersihan merupakan perilaku bersih untuk mencegah kontaminasi pada makanan yang ditangani. Prosedur yang penting bagi pekerja pengolah makanan adalah pencucian tangan, kebersihan dan kesehatan diri. Di Amerika Serikat 25% dari semua



penyebaran penyakit melalui makanan, disebabkan pengolahan makanan yang terinfeksi dan higiene perorangan yang buruk (Purnawijayanti, 2001).

1.2 TUJUAN UMUM

Sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan bagi unit kerja dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

1.3 TUJUAN KHUSUS

1. Memudahkan bagi tenaga gizi untuk membantu terciptanya kelancaran pelayanan makanan kepada pasien
2. Setiap tenaga gizi dapat bekerja berdasarkan Visi, Misi, Falsafah, dan tujuan Instalasi Gizi RS Prima Husada Sukorejo



BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT

2.1 DESKRIPSI RS PRIMA HUSADA

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berlokasi di Jalan Raya Surabaya – Malang km54, Desa Lemahbang kecamatan Sukorejo – Pasuruan, Telepon 0343 – 6745000 ,Email; info@rs-primahusada.com , www.rs-primahusada.com

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 2 Kepala Bidang dan 1 Kepala Bagian, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dimana dalam tugasnya dibantu oleh para kepala Instalasi dan Kepala Unit.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo menyediakan beberapa pelayanan yang meliputi :pelayanan Instalasi Gawat Darurat 24 Jam,instalasi Rawat Inap yang terdiri dari Kelas I,II,III dan VIP, Instalasi Kamar Operasi, Intensive Care Unit, Pelayanan Poli Spesialis yang terdiri dari pelayanan spesialis anak,spesialis bedah, spesialis bedah tulang, spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, spesialis syaraf,spesialis paru, pelayanan gigi dan mulut. Selain itu juga membuka pelayanan Laboratorium dan pelayanan radiologi.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2 SEJARAH INSTITUSI RS PRIMA HUSADA

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan :

Tahun 1990 – 2005	:	Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	:	Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	:	Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	:	Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2014	:	Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	:	Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	:	Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	:	Akreditasi Paripurna
Desember 2016	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Malang Raya Tahun 2016
April 2017	:	Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)
Desember 2017	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Jawa Timur Tahun 2017
		Pengembangan Gedung DPM
Desember 2017	:	Menjadi tempat dokter internsip
Februari 2018	:	Menjadi Rumah Sakit Umum dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
		Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
		Penetapan Rumah Sakit Tipe C



BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN RUMAH SAKIT

3.1 VISI PRIMA HUSADA

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

3.2 MISI PRIMA HUSADA

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3 FALSAFAH

Memberikan pelayanan secara profesional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

3.4 LANDASAN 7 NILAI BUDI UTAMA

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

3.5 TUJUAN

Rumah Sakit Prima Husada menjadi Rumah Sakit yang memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Malang dan sekitarnya

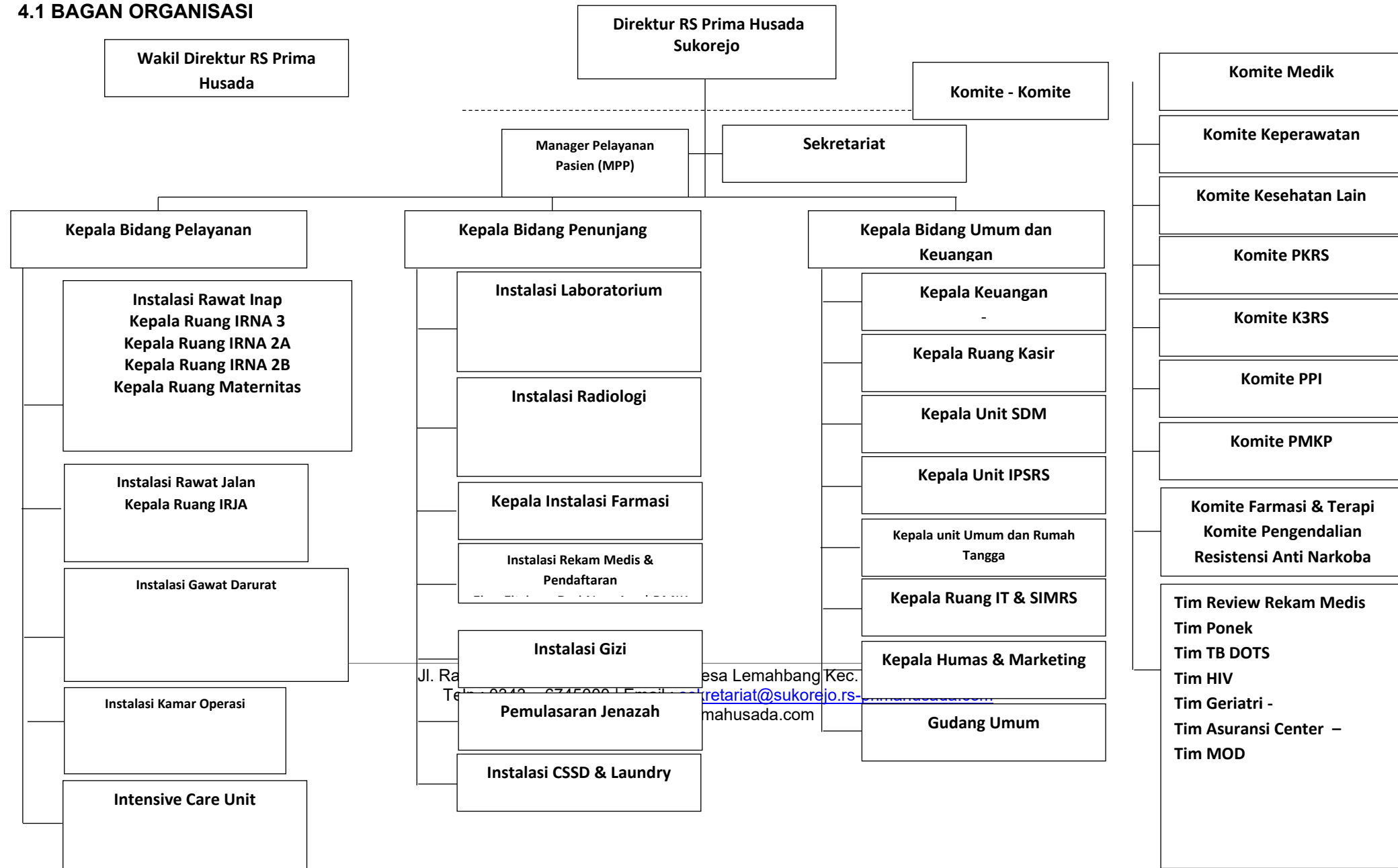
3.6 MOTTO

“Sahabat Menuju Sehat”

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI RS. PRIMA HUSADA

4.1 BAGAN ORGANISASI





4.2. KETERANGAN / PENGERTIAN

1. Unit Struktural

a. Direktur Rumah Sakit

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di RS Prima Husada Sukorejo

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit.
- 2) Kepala Bidang Penunjang Medik membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit.
- 3) Kepala Bagian Umum dan Keuangan membantu Direktur dalam bagian :
 - SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia .
 - Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.
 - Umum meliputi : Saranan dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tangga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak, dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.
 - Sistem Manajemen Rumah Sakit

c. Kepala Instalasi dan Kepala Unit

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :

- 1) Kepala Instalasi Rawat Jalan
- 2) Kepala Instalasi Rawat Inap
- 3) Kepala *Intensive Care Unit*
- 4) Kepala Instalasi Gawat Darurat
- 5) Kepala Instalasi Kamar Operasi
- 6) Kepala Instalasi Farmasi
- 7) Kepala Unit Rekam Medis
- 8) Kepala Unit Laboratorium
- 9) Kepala Unit Radiologi
- 10) Kepala Unit Gizi
- 11) Kepala Unit Laundry
- 12) Kepala Unit Sterilisasi
- 13) Kepala Unit Kamar Jenazah
- 14) Kepala Unit SDM
- 15) Kepala Unit Diklat
- 16) Kepala Unit Keuangan dan Akuntansi



- 17) Kepala unit SIM RS
- 18) Kepala Unit Rumah Tangga
- 19) Kepala Unit Pelayanan Pelanggan

2. Unit Non Struktural

Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/ Panitia / Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah sebagai berikut:

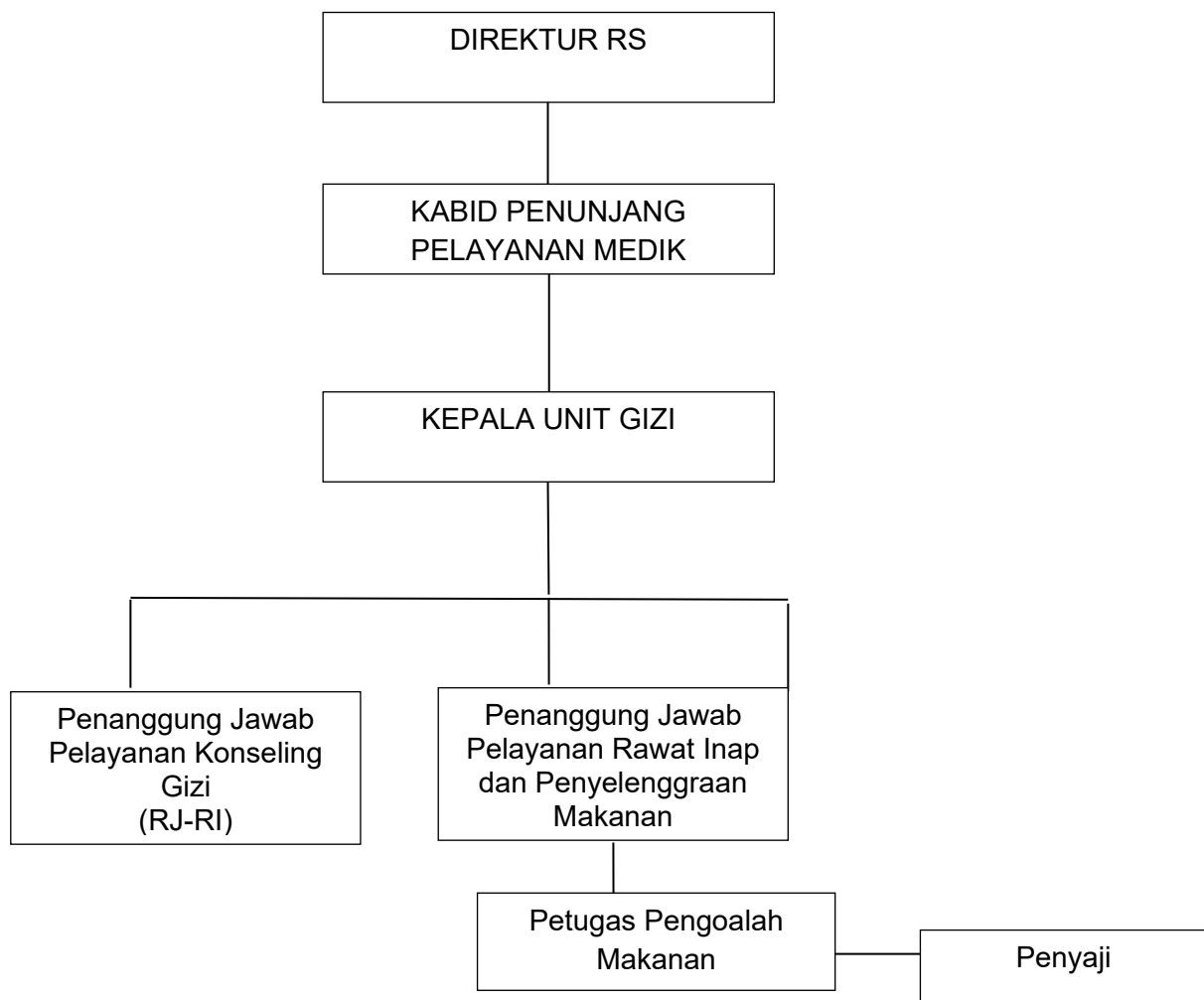
- a. Komite Medik
- b. Komite Keperawatan
- c. Komite Tenaga Kesehatan Lain
- d. Komite PPI
- e. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- f. Komite Farmasi & Terapi
- g. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
- h. Panitia K3RS)
- i. Tim Rekam Medis
- j. Tim TB DOTS
- k. Tim PONEK
- l. Tim Geriatri
- m. Tim HIV
- n. Tim PKRS
- o. Tim KMKB



BAB V

STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI GIZI

Instalasi Gizi dipimpin oleh Kepala Instalasi Gizi yang membawahi 3 penanggung jawab yaitu Penanggung Jawab Pelayanan Konseling Gizi Rawat Inap dan Rawat Jalan, Penanggung Jawab Penyelenggaraan Makanan, Penanggung Jawab Pelayanan Rawat Inap.



BAB VI

URAIAN JABATAN

6.1. URAIAN JABATAN

No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
1	Kepala Unit Gizi	1. Pendidikan : - Lulusan S1 Gizi atau DIII Gizi - Memiliki Surat Tanda Registrasi Ahli Gizi, Surat Sumpah Ahli Gizi - Memiliki Sertifikat Register Dietisien (bila sudah profesi) 2. Pengetahuan dan Keterampilan : Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 3. Pengalaman : Pengalaman di bidang klinis minimal 3 tahun
		Uraian tugas : - Menyusun dan melaksanakan perencanaan program dan anggaran Instalasi Gizi terkait SDM, Fasilitas, Pengembangan Pelayanan, Mutu, Keselamatan Pasien, dan Keselamatan Kerja Instalasi Gizi disesuaikan dan/atau berdasarkan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. - Berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Instalasi Gizi dan melaksanakannya. - Menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana. - Menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal-hal terkait di unitnya. - Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit. - Menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit. - Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. - Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggungjawab, serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas. - Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap gizi pelaksana. - Menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam



		menerima pelayanan. k. Memastikan pelayanan pasien sesuai pedoman pelayanan gizi dan standar prosedur operasional yang berlaku. l. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit. m. Menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya. n. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya. o. Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin. p. Menjaga proses kontrol mutu terhadap ikatan kerja sama yang ada. q. Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat.
		4. Tanggung Jawab a. Bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada. b. Bertanggungjawab atas pelayanan gizi rawat inap, rawat jalan, mspm di rumah sakit.
		5. Wewenang : a. Menandatangani surat pesanan dapur sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. b. Mengusulkan rencana kebutuhan tenaga gizi dari segi jumlah maupun kualifikasi di instalasi gizi. c. Mengevaluasi perencanaan kebutuhan dan mengajukan permintaan pengadaan barang-barang gizi baik untuk bulanan ataupun persediaan harian. d. Memantau penyelenggaraan dan pendistribusian makanan. e. Memantau penerapan SOP dan mengevaluasi..
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
2	Penanggung Jawab Pelayanan Konseling Gizi (Rawat Inap & Rawat Jalan)	1. Pendidikan : a. Lulusan S1 atau D3 Gizi b. Memiliki Surat Tanda Registrasi Ahli Gizi, Surat Sumpah Ahli Gizi 2. Pengetahuan dan Keterampilan : Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 3. Pengalaman : Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun
		a. Uraian tugas : b. Membantu menyusun dan melaksanakan program



		orientasi untuk pelaksana. c. Membantu menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal-hal terkait di unitnya. d. Melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit. e. Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. f. Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksana. g. Membantu menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. h. Melaksanakan pelayanan gizi klinik rawat jalan dan rawat inap sesuai pedoman pelayanan gizi dan standar prosedur operasional yang berlaku. i. Membantu melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit. j. Membantu menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya. k. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya. l. Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin. m. Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat.
		4. Tanggung Jawab : a. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Gizi. b. Bertanggung jawab atas pelayanan gizi rawat inap dan rawat jalan di Instalasi Gizi
		a. Wewenang b. Membantu Kepala Instalasi untuk melakukan tugas rutin di instalasi gizi rumah sakit. c. Melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya.
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
3	Penanggung Jawab Penyelenggaraan Makanan (Mspm)	1. Pendidikan : - Lulusan S1/D3 Gizi - Memiliki STR Tenaga Gizi yang masih berlaku, Surat sumpah Ahli Gizi 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak



		dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
		3. Pengalaman : Pengalaman di bidang MSPM minimal 1 tahun
		4. Uraian tugas : a. Mengkoordinasi tugas kerja dibagian dapur b. Merencanakan kebutuhan sediaan bahan makanan secara optimal. c. Mengadakan sediaan bahan makanan dan bahan habis pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. d. Mengawasi pemesanan, pembelian, penerimaan bahan makanan, bahan habis pakai, dan peralatan e. Menerima sediaan bahan makanan sesuai dengan spesifikasi yang berlaku. f. Memeriksa persediaan bahan yang mendekati waktu kadaluarsa g. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahan makanan dan bahan habis pakai. h. Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan sediaan bahan untuk penyelenggaraan makanan i. Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan
		5. Tanggung Jawab a. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Gizi b. Bertanggung jawab atas pelayanan dan ketenagaan keseharian di Instalasi Gizi
		6. Wewenang a. Membantu Kepala Instalasi untuk melakukan tugas rutin di gudang instalasi gizi rumah sakit meliputi penerimaan, pengolahan, distribusi, dan produksi makanan. b. Melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya.
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
4	Penanggung Jawab Pelayanan Gizi Rawat Inap	2. Pendidikan : a. Lulusan S1 atau D3 Gizi b. Memiliki Surat Tanda Registrasi Ahli Gizi, Surat Sumpah Ahli Gizi 2. Pengetahuan dan Keterampilan : Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 3. Pengalaman : Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun



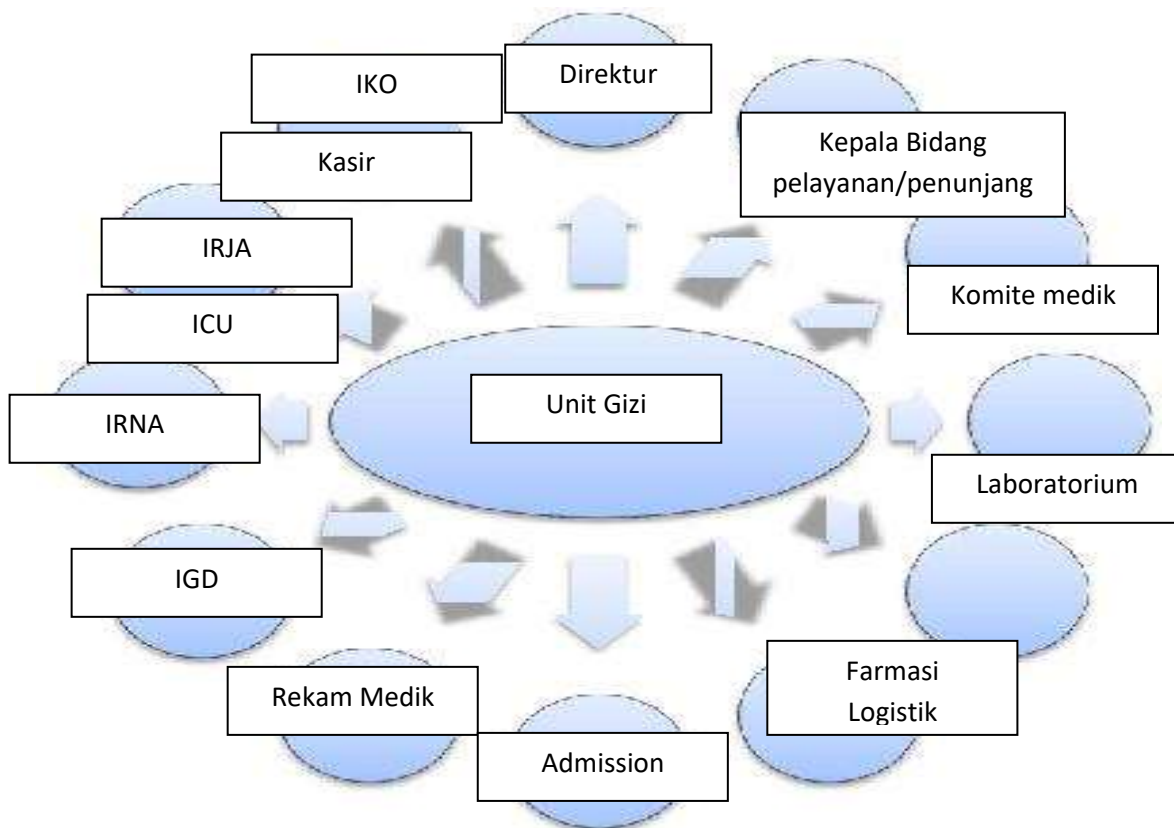
		a. Uraian tugas : b. Membantu menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana. c. Membantu menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal-hal terkait di unitnya. d. Melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit. e. Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. f. Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksana. g. Membantu menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. h. Melaksanakan pelayanan gizi klinik rawat inap sesuai pedoman pelayanan gizi dan standar prosedur operasional yang berlaku. i. Membantu melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit. j. Membantu menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya. k. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya. l. Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin. m. Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat.
		4. Tanggung Jawab : a. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Gizi. b. Bertanggung jawab atas pelayanan gizi rawat inap di Instalasi Gizi
		5. Wewenang a. Membantu Kepala Instalasi untuk melakukan tugas rutin di instalasi gizi rumah sakit. b. Melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya.
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
5.	Penjamah Makanan	1. Pendidikan : - Lulusan SMK Tata Boga 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Keterampilan dalam mengolah berbagai variasi makanan



		3. Pengalaman : Pengalaman di bidang jasa boga minimal 3 tahun
		4. Uraian Tugas a. Membantu gizi mspm untuk melakukan tugas rutin di instalasi gizi rumah sakit. b. Menyiapkan peralatan yang akan dipakai untuk proses pengolahan. c. Menyiapkan semua bumbu dan bahan makanan yang diolah d. Menghitung jumlah porsi makan yang akan diolah sesuai permintaan e. Mengolah semua bahan yang telah disiapkan sesuai menu
		5. Tanggung Jawab • Bertanggung jawab kepada gizi mspm dan Kepala Instalasi,
		6. Wewenang : Memberikan pelayanan terkait pengolahan dan penyajian makanan
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
7.	Penyaji Makanan	3. Pendidikan : - Lulusan SMK Tata Boga/Perhotelan/pariwisata 4. Pengetahuan dan Keterampilan : Keterampilan dalam memberikan service yang baik, dapat komunikasi efektif dengan baik 5. Pengalaman : Pengalaman di bidang service minimal 1 tahun
		6. Uraian Tugas a. Menyiapkan peralatan makan dan minum untuk pasien. b. Menyiapkan minum untuk pasien pagi. c. Membuat etiket pasien disesuaikan permintaan ruangan d. Membagi etiket makan pada baki/plato makan pasien sesuai kelas, ruang dan diet e. Kereta makan transit di pantry ruangan, penyaji mengambil daftar makan pasien diruang perawat dan mengkomunikasikan kepada perawat tentang diet/perubahan diet. f. Membagi makan pasien sesuai kamar, nama pasien, tanggal lahir pasien dan diet pasien. g. Mengambil semua peralatan yang kotor dari meja pasien
		7. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab kepada gizi rawat ianp dan Kepala Instalasi.
		8. Wewenang : Memberikan service penyajian makanan kepada pasien sesuai dengan jenis diet dan kamar pasien

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA



Dalam Tata hubungan kerja ini, Instalasi Gizi dengan unit terkait adalah melakukan kerjasama dalam hal memberikan keterangan jumlah karyawan dinas untuk penyediaan makanan bagi karyawan dan jumlah makanan untuk pasien sesuai kebutuhan pasien.

1. Tata hubungan Direktur dan Wakil Direktur dengan Instalasi Gizi
 - a. Direktur dan Wakil Direktur membuat kebijakan-kebijakan untuk Instalasi Gizi
 - b. Direktur dan Wakil Direktur memberitahukan adanya tamu yang harus dilayani Instalasi Gizi mengenai makanan, minuman, dan snack
2. Instalasi Rawat Jalan
 - a. Instalasi Rawat Jalan bekerja sama dengan Instalasi Gizi untuk pelayanan konsultasi pasien di Instalasi Rawat jalan
3. Instalasi Rawat Inap
 - a. Instalasi Rawat Inap bekerja sama dengan Instalasi Gizi dalam pengadaan makan pasien yang dirawat sesuai diet.
 - b. Instalasi Rawat Inap bekerja sama dengan Instalasi Gizi dalam pelayanan konsultasi gizi pasien



4. Instalasi Farmasi
Instalasi farmasi bekerjasama dengan instalasi gizi untuk pelayanan formula komersial untuk pasien yang membutuhkan.
5. Instalasi Gawat darurat
Instalasi Gawat darurat bekerjasama dengan Instalasi Gizi untuk pelayanan pemberian makan pasien one day care.
6. Instalasi laboratorium
Instalasi laboratorium bekerja sama dengan instalasi gizi untuk pelayanan bila ada tamu.
7. Instalasi Radiologi.
Instalasi radiologi memberikan informasi dokter tamu/dokter yang harus dilayani penyediaan minum dan snack.
8. Instalasi Rehab Medis
Instalasi rehab medis bekerjasama dengan instalasi gizi untuk pasien rawat jalan yang menjalani terapi dan membutuhkan konsultasi gizi.
9. Instalasi kamar operasi
 - a. Instalasi Kamar Operasi memberikan jumlah karyawan dinas yang akan dilayani pemberian makan.
 - b. Instalasi kamar Operasi memberikan jumlah dokter yang sedang operasi untuk dilayani pemberian makan.
10. Bagian Rekam Medis
 - a. Bagian rekam medis bekerjasama dengan instalasi gizi bila ada tamu yang perlu dilayani untuk pemberian minum.
 - b. Bagian rekam medis memberikan informasi identitas pasien yang memerlukan konsultasi gizi.
11. Bagian Pemasaran
Bagian pemasaran bekerja sama dalam memasarkan rumah sakit melalui cerkes, pojok sehat, mobil sehat dan lain-lain.
12. Bagian Keuangan
 - a. Bagian keuangan /kasir bekerjasama dalam urusan keuangan Instalasi Gizi.
 - b. Bagian Keuangan/kasir bekerjasama dalam penyetoran pendapatan instalasi gizi.
13. Bagian Sumber daya manusia
 - a. Instalasi gizi bekerja sama dengan bagian SDM dalam urusan penggajian.
 - b. Instalasi gizi bekerjasama dengan bagian SDM dalam urusan kepegawaian baik penerimaan pegawai, kenaikan golongan dan lain- lain.
 - c. Instalasi gizi bekerja sama dengan bagian SDM dalam pelatihan dan seminar.
14. Bagian Sistem Informasi Manajemen
Instalasi Gizi bekerja sama dengan bagian SIM dalam bidang IT.
15. Bagian Pemeliharaan sarana
Instalasi Gizi bekerja sama dengan BPS dalam pembuatan ataupun perbaikan peralatan di Instalasi gizi.
16. Bagian Inventori
 - a. Instalasi Gizi bekerja sama dengan bagian inventori dalam pemesanan dan pengadaan bahan makanan kering, bahan habis pakai.
 - b. Instalasi gizi bekerja sama dengan bagian inventori dalam pengadaan barang rumah tangga.



- c. Instalasi gizi bekerjasama dengan bagian inventori (unit HK) dalam inventaris peralatan, pelayanan tamu rumah sakit.

17. Bagian Administrasi

- a. Bagian administrasi memberikan informasi tentang surat menyurat.
- b. Bagian administrasi memberikan informasi tentang tamu rumah sakit yang memerlukan pelayanan makan.
- c. Bagian administrasi memberikan informasi tentang rapat-rapat didalam rumah sakit yang memerlukan pelayanan konsumsi.

BAB VIII**POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL****1. Penyusunan Pola Ketenagaan Sebagai Dasar Penempatan Staf**

Dalam upaya mempersiapkan tenaga gizi yang handal, perlu kiranya melakukan kegiatan menyediakan dan mempertahankan sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi. Atas dasar tersebut perlu adanya perencanaan SDM, yaitu proses mengantisipasi dan menyiapkan tenaga dengan kualifikasi sesuai standar. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Perencanaan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai sasarannya melalui strategi pengembangan kontribusi acuan yang digunakan menggunakan perhitungan.

Berdasarkan penelitian Badan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia kesehatan tahun 2012 mengenai kebutuhan tenaga gizi dengan metode perhitungan Analisis Beban Kerja, diperoleh jumlah optimal tenaga RD dan TRD menurut kelas rumah sakit agar dapat melaksanakan pelayanan gizi yang baik dan berkualitas untuk menjamin keamanan pasien. Kebutuhan RD dan TRD digambarkan pada tabel berikut :

Tabel.1 Kebutuhan Tenaga Gizi Berdasarkan Kelas Rumah Sakit

No	Rumah Sakit	Registered Dietisien (RD)	Teknikal Registered Dietisien (TRD)	Kebutuhan Tenaga Gizi
1	Kelas A	56	16	72
2	Kelas B	22	15	37
3	Kelas C	18	12	30
4	Kelas D	9	14	23

Pada Rumah Sakit yang belum memiliki tenaga gizi sesuai klasifikasi sebagai mana tersebut, dapat memanfaatkan tenaga gizi yang dimiliki dengan secara bertahap melakukan peningkatan kemampuan dan pembinaan tenaga tersebut agar memenuhi kualifikasi termaksud. Dan jumlah tenaga gizi yang ada di Rumah Sakit Prima Husada yang ada dan dapat dimanfaatkan sejumlah 4 orang.

A. Perhitungan Pola Ketenagaan Gizi Berdasarkan Beban Kerja (Permendagri No.12 tahun 2008)

No	Tugas Pokok	Uraian Tugas	Rerata Volume Kerja Perhari	Waktu Yang Dibutuhkan	
				Satuan	Jumlah
1	QC (Quality Control)	Melakukan control terhadap makanan dari segi rasa, tampilan dan kebersihan	100	15 Menit	1500
2	Mengisi status	Mengerjakan asuhan gizi dari	40	10	400



No	Tugas Pokok	Uraian Tugas	Rerata Volume Kerja Perhari	Waktu Yang Dibutuhkan	
				Satuan	Jumlah
	pasien	pengkajian awal hingga rencana intervensi dan monitoring evaluasinya		menit	
3	Visite pasien	Mengedukasi pasien terkait diet sesuai dengan kasus nya	30	10 menit	300
4	KIE Rawat Inap	Mengedukasi pasien baru atau mengedukasi pasien yang akan pulang di rawat inap	25	5 menit	125
5	KIE Rawat Jalan	Mengerjakan asuhan gizi rawat jalan	5	20 menit	100
		Mengedukasi diet pasien sesuai dengan diagnose pasien dan dilakukan di rawat jalan	5	10 menit	50
Jumlah waktu					2475
Jam kerja					420
Total kebutuhan Karyawan					5,89

B. Perhitungan Pola Ketenagaan petugas dapur Berdasarkan Beban Kerja (Permendagri No.12 tahun 2008)

No	Tugas Pokok	Uraian Tugas	Rerata Volume Kerja Perhari	Waktu Yang Dibutuhkan	
				Satuan	Jumlah
1	Menerima bahan makanan	Melakukan pengecekan bahan makanan yang di epsan sesuai dengan spesikasi	1	45 menit	45
2	Menyelia bahan makanan	Melakukan penyortiran bahan makanan dan pencucian bahan makanan	2	150 menit	300
		Menyortir buah-buahan	3	60 menit	180
2	Memotongi bahan makanan	Melakukan pemotongan bahan makanan sesuai dengan ukuran	3	180 menit	540
3	Penyimpanan bahan makanan	Menyimpan bahan makanan sesuai dengan	2	60 menit	120



No	Tugas Pokok	Uraian Tugas	Rerata Volume Kerja Perhari	Waktu Yang Dibutuhkan	
				Satuan	Jumlah
		jenis bahan basah atau bahan kering			
4	Pengolahan makanan	Melakukan pengolahan makanan sesuai dengan menu pasien	4	180 menit	720
		Membersihkan ruang pengolahan	3	90 menit	270
		Menyiapkan Minuman pasien	3	60	180
		Melakukan Pengolahan makanan event Rumah sakit	1	90 menit	90
5	Pemorsian makanan	Memorsi makanan sesuai dengan takaran yang dianjurkan gizi dan sesuai diet pasien	4	150 menit	600
		Memorsi minuman pasien	3	45	135
		Membersihkan tempat pemorsian	4	120 menit	480
6	Pendistribusian makanan	Membagikan makanan ke kamar pasien sesuai dengan diet dan ruangan pasien	4	150 menit	600
Jumlah waktu					4260
Jam kerja					420
Total kebutuhan Karyawan					10, 14

Keterangan :

- WPT = Waktu Penyelesaian Tugas
- WKE = Waktu Kerja Efektif

$$\frac{\sum WPT}{\sum WKE} \times 1 \text{ Orang} = 1000 : 420 \times 1 \text{ orang} = 2 \text{ orang}$$



$$\frac{\sum WPT}{\sum WKE} \times 1 \text{ Orang} = 1760 : 420 \times 1 \text{ orang} = 4 \text{ orang}$$

Perhitungan pola ketenagaan instalasi gizi menggunakan pola ABK (Permendagri No.12 tahun 2008) didapatkan jumlah ahli gizi sebanyak 6 orang, dan petugas dapur sebanyak 10 orang, apabila ada penambahan gedung rawat inap atau jumlah tempat tidur, maka akan dilakukan penambahan ahli gizi dan petugas dapur secara bertahap dan akan dievaluasi kinerja pada saat pelayanan berlangsung agar berjalan dengan efektif dan efisien.

C. Pengaturan Jaga di Instalasi Gizi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah sebagai berikut :

No.	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu Kerja	Jumlah SDM
1	Kepala Instalasi Gizi	1 Shift	06.30–14.00	1 Orang
2	Ahli Gizi	3 Shift	Pagi : 05.00–13.00 Non Shift : 08.00 – 16.00 Middle: 10.00-18.00	5 Orang
3	Juru Masak	3 Shift	Pagi : 03.00-12.00 Siang: 06.00-15.00 Middle Shift : 09.00-18.00	1 Orang
4	Asisten juru masak	3 Shift	Pagi : 03.00-12.00 Siang: 06.00-15.00 Middle : 09.00-18.00	3 Orang
5	Pemorsian	3 Shift	Pagi : 03.00-12.00 Siang: 06.00-15.00 Middle : 09.00-18.00	2 Orang
6	Penyaji	3 Shift	Pagi : 03.00-12.00 Siang: 06.00-15.00 Middle : 09.00-18.00	2 Orang

8.1. Seleksi Calon Karyawan

Seleksi calon karyawan adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk mengundang para pelamar sebanyak mungkin sehingga Instalasi Gizi memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Seleksi calon karyawan dilakukan karena berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, ditemukan jumlah pasien dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

Berdasarkan sumber seleksi calon karyawan dapat dibagi dua yaitu:

1. Dari dalam RS. Prima Husada Sukorejo sendiri (*internal resources*)

Menarik calon dari dalam RS Prima Husada Sukorejo sendiri (*Internal resources*) memiliki keuntungan lebih yaitu calon sudah dikenal dengan kinerja yang baik dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dibanding menarik calon dari luar RS Prima Husada. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui berkas-berkas



pelamar yang masuk ke rumah sakit Prima Husada

2. Dari luar RS. Prima Husada Sukorejo (*external resources*)

Proses penarikan calon dari luar RS. Prima Husada Sukorejo ini dapat dilakukan dengan cara iklan media cetak dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tentang kebutuhan dengan kualifikasi tertentu.

Kriteria calon karyawan menurut standar Gizi RS Prima Husada Sukorejo:

1. Ahli Gizi

- a. Lulusan D3/S1 Gizi.
- b. Berasal dari Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi B.
- c. Memiliki IPK minimal 2,75 untuk Perguruan Negeri, IPK minimal 3,00 untuk Perguruan Swasta.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Memiliki pemahaman tentang Pelayanan Gizi RS dengan baik.
- f. Mudah bekerja secara mandiri dan tim

8.2. Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Gizi khususnya dan Rumah Sakit Prima Husada umumnya, diperlukan pembinaan/pengembangan kompetensi tenaga gizi. Pembinaan/ pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan tugas dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan menambah pengetahuan wawasan bidang pelayanan gizi.

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Pendidikan

Tenaga dengan pendidikan setingkat SMA diberi ijin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan DIII.

2. Pelatihan

Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Ahli Gizi di Instalasi Gizi dilaksanakan melalui :

Internal Training yaitu program pelatihan yang diselenggarakan oleh RS Prima Husada Sukorejo, yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan PPI dasar dan standar keselamatan pasien, komunikasi efektif, pelatihan apar dan BHD

External Training yaitu program pelatihan diluar rumah sakit yang diikuti sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya mutu pelayanan Instalasi Gizi.

8.3. Pola Ketenagaan Dan Kualifikasi SDM Instalasi Gizi

Penyusunan Pola Ketenagaan Sebagai Dasar Penempatan Staf

Dalam upaya mempersiapkan tenaga gizi yang handal perlu adanya perencanaan SDM. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi	Kebutuhan
-----	--------------	-------------	-----------

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



		Pendidikan	Sertifikasi/Pelatihan	
1.	Ka unit Gizi	S1 Gizi	HACCP Nutrition Care Process Mutu dan kes. Px PPI	1 orang
2.	Gizi Pelaksana	S1 Gizi	HACCP Nutrition Care Process Mutu dan kes. Px PPI	4 Orang
3.	Gizi Pelaksana	D3 Gizi	HACCP Nutrition Care Process Mutu dan kes. Px PPI	1 Orang
4.	Bagian pengolahan	SMA/K	Mutu dan kes. Px PP	4 Orang
5.	Bagian pengolahan	SMP	Mutu dan kes. Px PP	-
6.	Bagian Pemorsian	SMA/K	Mutu dan kes. Px PP	2 Orang
7.	Bagian Pemorsian	SMA/K	Mutu dan kes. Px PP	-
8.	Bagian Penyaji	SMA/K	Mutu dan kes. Px PP	2 Orang
9.	Bagian Penyaji	SMA/K	Mutu dan kes. Px PP	-
10.	Bagian Penyaji	SMA/K	Mutu dan kes. Px PP	-
11.	Bagian Penyaji	SMA/K	Mutu dan kes. Px PP	-

2. Penempatan dan Penempatan Kembali Staf

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat jalan lain.

Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf;
 - Staf yang mempunyai kompetensi tambahan seperti pelatihan Instrumen, pelatihan



Kegawatdaruratan Perinatologi, Pelatihan ICU dasar, Pelatihan Anestesi tidak dapat dirotasi ke unit lain dikarenakan terdapat unit prioritas yang khusus membutuhkan kompetensi tambahan tersebut. Misalnya Staf yang memiliki pelatihan Instrumen, ditempatkan di Unit Kamar operasi, sebaliknya staf yang mempunyai kompetensi ICU dasar di tempatkan di *Unit Care Unit* (ICU)

- Penempatan staf dapat dilakukan apabila dalam unit tersebut terdapat kebutuhan mendesak sedangkan staf yang dibutuhkan belum tersedia, maka staf tersebut di rotasi sementara untuk menjaga stabilitas pelayanan dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan Rincian Kewenangan Klinis yang sesuai.
- b. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama;
Mengkaji keinginan staf untuk ditempatkan pada unit yang sesuai berdasarkan hasil psikotest, menggali nilai kepribadian staf apakah lebih berpotensi pada unit pelayanan atau manajemen, atau bahkan marketing yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit
- c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi, surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang telah disetujui Direktur RS Prima Husada dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap staf mempunyai tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kompetensi dan kewenangan menjadi dasar dalam menentukan penempatan, uraian pekerjaan, dan kriteria untuk evaluasi kinerja staf.

Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga kesehatan profesional dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Staf yang bekerja terutama di bidang manajemen dan fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Unit Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah harus mempunyai STR, SIP, SPK, RKK dan sebagai kepala unit kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
- b. seseorang dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya;
- c. bagi mereka yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman. Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada uraian tugasnya. (contoh, penugasan penuh waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara)

BAB IX

KEGIATAN ORIENTASI

9.1 Kegiatan Orientasi di Instalasi Gizi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan gizi yang profesional di RS Prima Husada, maka dilakukan kegiatan orientasi/ pengenalan lingkungan kerja (*on job training*) yang dilakukan pada petugas gizi baru.

Kegiatan orientasi memberikan pengarahan dan bimbingan serta mempersiapkan petugas gizi agar dapat bekerja cepat dan tepat sesuai dengan peran dan fungsinya.

9.2 Kegiatan Orientasi

Hari ke	Materi	Waktu	Metoda	Penanggung Jawab
Hari ke I	• Tujuan orientasi, sejarah, visi, misi, motto RSPH, struktur organisasi RSPH	1 jam	Ceramah	Latbang
	• Peraturan kepegawaian/KKB	1 jam	Ceramah	Latbang
	• Service Excellent	1 jam	Ceramah	Marketing
	• Fasilitas , sarana, produk-produk RSPH	1 jam	Ceramah	Marketing
	• Etika dan Hukum	1 jam	Ceramah	Panitia Etik
	• Kebijakan pelayanan gizi	1 jam	Ceramah	Karu Gizi
	• Uraian tugas gizi	1 jam	Ceramah	Karu Gizi
	• Alur dan prosedur penerimaan barang datang sampai pendistribusian makanan	2 jam	Ceramah	Karu Gizi
	• Alur dan tata laksana pemeriksaan penunjang medis, farmasi, gizi	2 jam	Ceramah	Asmen Jangdik
	• Penjelasan tentang asuhan gizi	2 jam	Ceramah	Karu Gizi
Hari ke II	• Pelaksanaan Asuhan Gizi	2 jam	Praktek	Karu Gizi
	• Sosialisasi SPO gizi	2 jam	Diskusi	Karu Gizi
	• Melakukan pemesanan makanan pasien rawat inap	2 jam	Praktek dan diskusi	Karu Gizi
Hari ke III	• Melaksanakan Konsultasi Gizi rawat inap	1 jam	Praktek	Karu Gizi
	• Melaksanakan Konsultasi Gizi rawat jalan	1 jam	Praktek	Karu Gizi
Hari ke	• Mengikuti kerja yang sebenarnya dengan	1 shift	Praktek	Karu Gizi



Hari ke	Materi	Waktu	Metoda	Penanggung Jawab
IV	pendampingan.			
Hari ke V	Mengikuti kerja yang sebenarnya selama 2 minggu dengan di dampingi kepala ruang	1 shift	Praktek	Karu Gizi



BAB X

PERTEMUAN / RAPAT

10.1 Pengertian

Rapat merupakan suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah tertentu

10.2 Tujuan

1. Dapat menggali segala permasalahan terkait dengan pelayanan gizi yang diberikan
2. Dapat mencari jalan keluar atau pemecahan masalah yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan

10.3 Kegiatan Rapat

Rapat dilakukan / diadakan oleh unit gizi yang dipimpin oleh kepala instalasi dan diikuti seluruh staf yang berada dibawah unit kerjanya

10.4 Jenis Rapat Instalasi Gizi terdiri dari :

1. Rapat Rutin
 - 1) Rapat koordinasi antar unit diselenggarakan pada setiap rabu jam 13.30 s/d selesai di Hall Andalusia. Rapat ini dihadiri oleh kepala instalasi, kepala ruangan, dan unit-unit terkait untuk membahas tentang koordinasi antar unit dalam satu RS.
 - 2) *Daily report* dilakukan setiap hari jam 13.00-14.00 yang bertempat di Hall Andalusia. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing unit untuk membahas permasalahan di masing-masing unit serta update informasi terbaru mengenai RS Prima Husada Sukorejo.
 - 3) Rapat Internal Instalasi Gizi setiap 1 bulan sekali
Waktu : Setiap Jum'at Minggu ke 2
Jam : 09.00-selesai
Tempat : Ruang Gizi
Peserta : Manajer Pelayanan, Asmen Penunjang Medik, Ka.Instalasi, Ka. Ruang, dan Pelaksana
Materi:
 - o Evaluasi Kinerja Mutu
 - o Evaluasi SDM dan Fasilitas Gizi
 - o Permasalahan yang ada serta pemecahannya
 - o Evaluasi dan Rekomendasi
2. Rapat Insidentil
Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu apabila ada masalah atau hal-hal yang perlu dibahas segera



BAB XI

PELAPORAN

11.1 Pengertian

Pelaporan merupakan sistem atau metode yang dilakukan untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang ada terkait dengan pemberian asuhan gizi di instalasi gizi

11.2 Jenis Laporan

Laporan dibuat oleh tiap-tiap kepala ruang gizi. Adapun jenis laporan yang dilakukan terdiri dari :

1. Laporan Harian

Laporan harian berupa pencatatan jumlah makanan diet pasien rawat inap, pencatatan data/register pasien rawat inap dan rawat jalan yang mendapatkan asuhan gizi berupa konsultasi gizi.

2. Laporan Bulanan

Laporan yang dibuat oleh kepala ruang dalam bentuk tertulis setiap bulannya dan diserahkan kepada Sekretariat tiap tanggal 3. Adapun hal-hal yang dilaporkan adalah :

- a. Laporan SDM Gizi yang meliputi :
 1. Kuantitas SDM
 2. Kualitas SDM
- b. Laporan fasilitas dan sarana Gizi yang meliputi :
 1. Kelengkapan alat dan fasilitas
 2. Kondisi alat dan fasilitas
- c. Laporan Produktivitas Gizi yang meliputi :
 1. Jumlah pemberian diet pasien
 2. Jumlah KIE Rawat Inap
 3. Jumlah KIE rawat Jalan
- d. Laporan Kinerja Mutu
 1. Indikator mutu pelayanan
 2. Indikator Keselamatan Pasien

11.3 Laporan Tahunan

Laporan yang dibuat oleh Karu dalam bentuk tertulis setiap tahun dan diserahkan kepada kepala Instalasi Gizi tiap tanggal 5. Adapun hal-hal yang dilaporkan adalah :

- a. Laporan SDM Gizi Dan Evaluasi Dalam Satu Tahun
- b. Laporan Fasilitas Dan Sarana Gizi Dan Evaluasi Dalam Satu Tahun
- c. Laporan Produktivitas Gizi Dan Evaluasi Dalam Satu Tahun
- d. Laporan Kinerja Mutu Pelayanan Gizi Dan Evaluasi Dalam Satu Tahun

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep